NEURO · NE-03

# Traumatisme crânien · rachis cervical

**NICE NG232 (2023) · CCR**
indications et délais du scanner chez l'adulte et l'enfant

## SCANNER CÉRÉBRAL · ADULTE (≥ 16 ANS)

**Scanner dans l'heure**

- GCS ≤ 12 à l'arrivée aux urgences
- GCS < 15 deux heures après le traumatisme
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base : hémotympan, ecchymose périorbitaire, rhinorrhée ou otorrhée de LCR, signe de Battle
- Crise convulsive post-traumatique
- Déficit neurologique focal
- Plus d'un vomissement

**Scanner dans les 8 h**

- Traitement **anticoagulant** (hors aspirine seule) : à envisager dans les 8 h, même sans autre facteur de risque
- Perte de connaissance ou amnésie, associée à : âge ≥ 65 ans, trouble de l'hémostase, mécanisme dangereux (piéton, éjection, chute > 1 m ou 5 marches), amnésie rétrograde > 30 min

**Enfant (NICE NG232)** : scanner dans l'heure si suspicion de maltraitance, convulsion post-traumatique, GCS < 14 (< 15 avant 1 an), GCS < 15 à 2 h, fontanelle tendue, signe de fracture de la base, déficit focal, ecchymose ou plaie > 5 cm avant 1 an ; ou si ≥ 2 critères parmi PC > 5 min, somnolence, ≥ 3 vomissements, mécanisme dangereux, amnésie > 5 min (1 seul : surveillance 4 h).

## CANADIAN CT HEAD RULE (ADULTE, GCS 13–15, PERTE DE CONNAISSANCE OU AMNÉSIE)

**Haut risque (lésion neurochirurgicale)**

- GCS < 15 à 2 h
- Suspicion de fracture ouverte ou embarrure
- Signe de fracture de la base
- ≥ 2 vomissements
- Âge ≥ 65 ans

**Risque moyen (lésion au scanner)**

- Amnésie rétrograde ≥ 30 min
- Mécanisme dangereux : piéton renversé, éjection d'un véhicule, chute > 1 m ou 5 marches

Règle non applicable : anticoagulés, convulsions, âge < 16 ans, traumatisme pénétrant.

## RACHIS CERVICAL · CANADIAN C-SPINE RULE (ADULTE CONSCIENT, GCS 15, STABLE)

**1 · Facteur de haut risque ?**
Âge ≥ 65 ans, mécanisme dangereux, paresthésies des membres
**Oui → imagerie**

›

**2 · Facteur de bas risque permettant l'examen ?**
Choc arrière simple, assis aux urgences, a marché, douleur retardée, pas de douleur médiane
**Aucun → imagerie**

›

**3 · Rotation active 45° droite et gauche ?**
**Oui → pas d'imagerie**
**Non → imagerie**

Adulte : **scanner** en 1re intention si imagerie indiquée (plutôt que radiographies). IRM si déficit neurologique ou suspicion de lésion ligamentaire. Non applicable : grossesse, paralysie aiguë, rachis pathologique, âge < 16 ans.

## LECTURE DU SCANNER · CHECK-LIST

**Collections**
extradurale (biconvexe), sous-durale (croissant), hémorragie sous-arachnoïdienne et intraventriculaire

**Parenchyme**
contusions, lésions axonales diffuses (IRM plus sensible), œdème

**Effet de masse**
déviation de la ligne médiane en mm, engagement, citernes

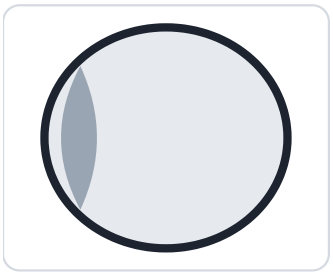
**Os**
fenêtre osseuse, reconstructions 3D, base du crâne, rochers, face

# Traumatisme crânien · rachis cervical (suite)

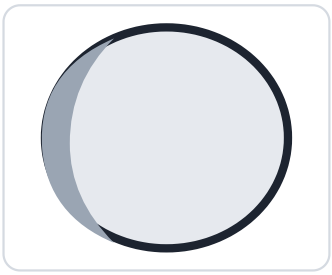


## ATLAS VISUEL

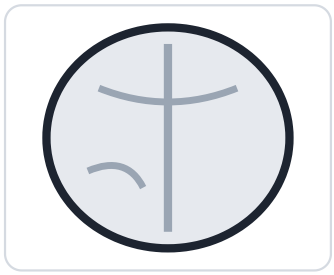
### Collections et lésions post-traumatiques



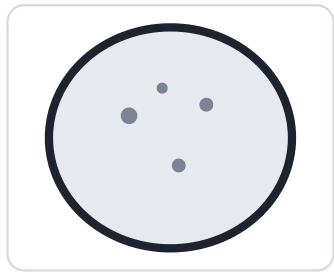
**Extradural**
biconvexe, ne franchit pas les sutures



**Sous-dural**
croissant, franchit les sutures



**Sous-arachnoïdienne**
sillons, citernes, scissures



**Lésions axonales diffuses**
pétéchies jonctionnelles · IRM (SWI)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Hématome extradural**
Radiopaedia · aspect, pièges
radiopaedia.org/articles/extradural-haemorrhage

**Hématome sous-dural**
Radiopaedia · âges de l'hématome
radiopaedia.org/articles/subdural-hemorrhage-2?l

**Lésions axonales diffuses**
Radiopaedia · grades, IRM
radiopaedia.org/articles/diffuse-axonal-injury

**Canadian CT Head Rule**
Radiopaedia · critères
radiopaedia.org/articles/canadian-ct-head-rule?l

**Protocole scanner cérébral**
Radiopaedia · acquisition et fenêtres
radiopaedia.org/articles/ct-head-protocol?lang=u

**NICE NG232 (2023)**
Recommandation complète
www.nice.org.uk/guidance/ng232

**Sources :** NICE NG232 Head injury (2023) – www.nice.org.uk/guidance/ng232/resources/head-injury-assessm... · Canadian C-Spine Rule – www.neuropt.org/docs/default-source/cpgs/concussion/concussi... · Cochrane – CCR et NEXUS – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6494628/